Si desea mayor información acerca de las enfermedades de la glándula tiroides, puede comunicarse con las siguientes organizaciones:

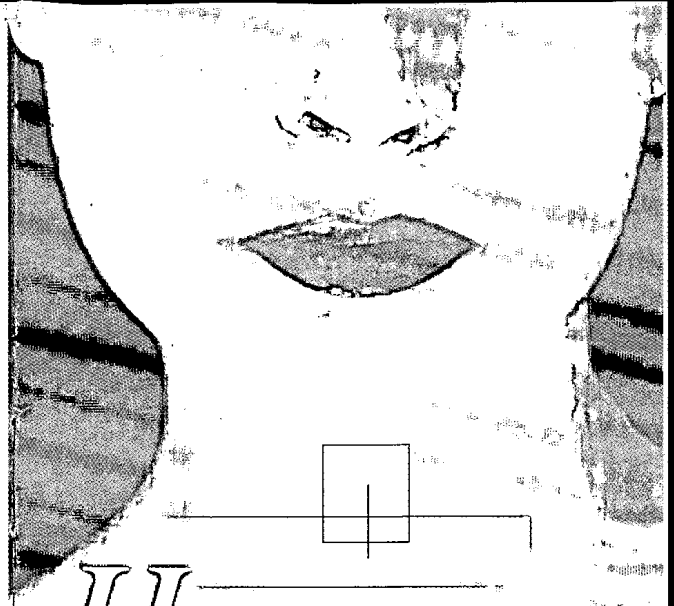
American Foundation of Thyroid Patients
P.O. Box 820195
Houston, TX 77282-0195
(281) 496-4460

Thyroid Foundation of America, Inc.
Ruth Sleeper Hall 350
Parkman Street
Boston, Massachusetts 02114
(800) 832-8321

The Thyroid Society
7515 South Main Street
Suite 545
Houston, Texas 77030
(800) 849-7643

American Thyroid Association
Montefiore Medical Center
111 East 210th Street
Bronx, New York 10467
(718) 882-6047

JONES PHARMA INCORPORATED
1945 Craig Road, P.O Box 46903
St. Louis, MO 63146
800-525-8466
(NASDAQ: JMED)
www.jmedpharma.com



Hipotiroidismo

Obtenga La Información

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es una afección en la que el cuerpo carece de una cantidad adecuada de la hormona tiroidea. Si su médico le ha diagnosticado que padece de hipotiroidismo, usted es uno entre cinco millones de personas en los Estados Unidos que padecen de esta común afección. Es posible que hasta un 10 por ciento de la población femenina padezca una cierta deficiencia de la hormona tiroidea. Las causas más comunes del hipotiroidismo son la inflamación de la glándula tiroides y el tratamiento previo a consecuencia del exceso de funcionamiento de la glándula tiroides.

Las personas con hipotiroidismo pueden experimentar los siguientes síntomas:

Fatiga
Debilidad
Aumento de peso o
dificultad cada vez mayor para adelgazar
Intolerancia al frío
Dolores y calambres musculares
Estreñimiento
Depresión
Pérdida de la memoria
Menstruación irregular

SÍNTOMAS QUE NOTAN OTRAS PERSONAS

Hinchazón de la cara y las manos
Lentitud de movimiento
Irritabilidad
Disminución de la libido
Cabello áspero y seco
Piel seca, áspera y pálida
Pérdida de cabello

NOTAS

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TIROIDES

Análisis	Abreviatura	Límites normales
Serotiroxina	T4	4.6-12µg/dl
Fracción de tiroxina libre	FT4F	0.03-0.005%
Tiroxina libre	F T4	0.7-1.9 NG/DL
Coeficiente de enalce de la hormona tiroides	THBR	0.9-1.1
Índice de tiroxina libre	F T4I	4-11
Serotrilodotironina	T3	80-180 NG/DL
Trilodotironina libre	F T3	230-619 PG/DL
Índice de trilodotironina libre	F T3I	80-180
Captura de yodo radioactivo	RAIU	10-36%
Serotirotrofina	TSH	0.5-6µU/ML
Capacidad de globulina de enlace con la tiroxina	TBG	12-20 µg/dl T4 + 1.8 ugm
Análisis de estimulación de THR		Máximo TSH 9- 30 µIU/ml a 20-30 min.
Serotiroglobulina	Tg	0-30 ng/ml
Título de anticuerpos tiroides microsomas	TMAb	Varía según el método
Título de anticuerpos tiroglobulinos	TgAb	Varía según el método

Los valores normales varían de un laboratorio a otro

La cantidad y severidad de los síntomas varían dependiendo de la duración y el nivel de deficiencia de la hormona tiroidea. Prácticamente cualquiera de los síntomas puede constituir el principal problema en un paciente y, sin embargo, ser de menor importancia en otro paciente, o inclusivo ni surgir en otro.

De hecho algunas personas que padecen de hipotiroidismo no muestran síntoma alguno.

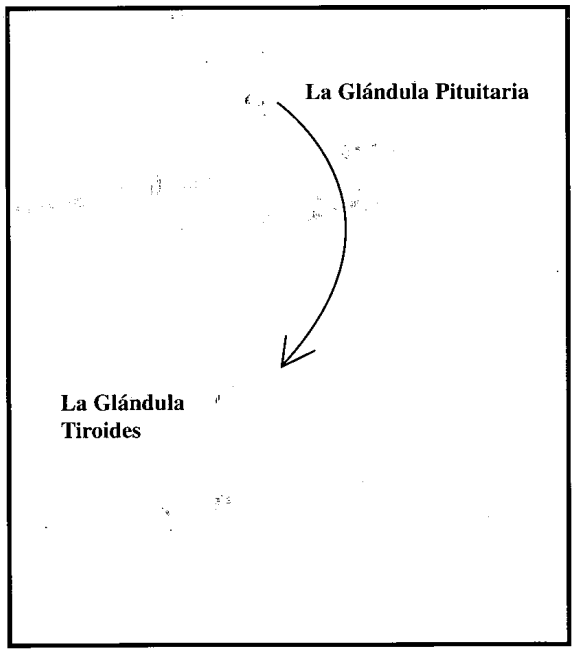
El hipotiroidismo puede ocasionar la inflamación o agrandamiento de la glándula tiroides, ubicada en la base del cuello. Aunque el agrandamiento de la glándula quizás no se note a simple vista, el primer síntoma de la inflamación de la tiroides (también denominada "bocio") podría ser una sensación de rigidez en el cuello.

Si no se recibe el tratamiento adecuado, el hipotiroidismo, así como los síntomas que le acompañan, generalmente empeoran con el tiempo. En casos muy contados las complicaciones pueden tener como resultado una grave depresión que puede poner en peligro la vida del paciente, producir insuficiencia cardíaca o coma.

El hipotiroidismo se puede diagnosticar fácilmente mediante un análisis de sangre y se puede corregir completamente mediante tratamiento médico.

LA GLÁNDULA TIROIDES

La tiroides es una glándula en forma de mariposa, ubicada en el cuello, delante de la tráquea. Su función es producir la hormona tiroidea, la levotiroxina (T4), la cual, a su vez, se convierte en triyodotironina (T3) en otros tejidos del cuerpo. Estas dos hormonas tiroideas, la T4 y la T3, se desplazan por la sangre llegando a todas partes del cuero, incidiendo en el metabolismo. Entre otras cosas, el metabolismo se refiere a la manera en que el cuerpo humano quema las calorías, las grasas y los azúcares y produce músculos. Las hormonas tiroideas también afectan de manera muy específica muchos órganos del cuerpo, por ejemplo, pueden acelerar el ritmo cardiaco.



Recuerde...

- Use la medicina siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su médico.
- Avise de inmediato a su médico si cree experimentar síntomas de exceso o deficiencia de la hormona tiroidea.
- Acuda a todas las citas fijadas por su médico, para asegurarse de mantener su hipotiroidismo bajo control.

Es especialmente importante que los pacientes con deficiencias cardíacas obtengan la dósis óptima de esta hormona. Cualquier exceso, por ligero que sea, puede aumentar el riesgo de un ataque cardíaco o empeorar la angina de pecho del paciente. El médico puede prescribir revisiones más frecuentes de la dosis. Comuníquese con su médico si desarrolla cualquier otro problema médico mientras utiliza el medicamento recetado.

La T4 se puede tomar junto con otras medicinas. Los pacientes que tomen colestiramina (un compuesto reductor del colesterol en la sangre), carafate (usado para las úlceras estomacales), digoxina (utilizada en pacientes con problemas cardíacos), o medicamentos contra los ataques epilépticos, deben consultar con su médico acerca de las posibles contraindicaciones. Las mujeres que estén tomando T4 y queden embarazadas no se deben preocupar, ya que el medicamento producirá exactamente la cantidad de hormonas que produciría su glándula tiroides en condiciones normales. Sin embargo, deben consultar con su médico, puesto que podría ser necesario modificar la dosis de T4 durante la gestación.

Su médico debe revisar los niveles de hormona tiroidea y de TSH por lo menos una vez al año, para asegurarse de que se administra la cantidad óptima de hormona tiroidea.

A usted probablemente le recetarán una de las tres marcas de tabletas de levotiroxina disponibles en el mercado. Si lo desea, puede consultar con su médico o farmacia cuál es la marca más económica.

Normalmente, la glándula pituitaria (o glándula maestra) hace que la glándula tiroides normal produzca la cantidad correcta de hormona tiroidea. La pituitaria controla constantemente el nivel de hormona tiroidea presente en la sangre y produce su propia hormona, denominada hormona estimuladora de la tiroides (TSH), que se desplaza por la sangre hasta llegar a la tiroides, estimulándola para que produzca más hormonas tiroideas.

Si la glándula tiroides se inflama o sufre alguna otra afección, es posible que no pueda producir el suficiente nivel de hormona tiroidea que necesita el cuerpo. La causa más común de insuficiencia tiroidea es lo que se denomina tiroiditis autoinmunológica (o enfermedad de Hashimoto), un tipo de inflamación tiroidea causada por el sistema inmunológico del propio paciente. Normalmente, nuestro sistema inmunológico sólo combate a los invasores externos como las bacterias, y nunca ataca las diferentes partes de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, cuando se presenta la tiroiditis autoinmunológica, el sistema inmunológico causa daños a la glándula tiroidea del propio paciente (afortunadamente, el sistema inmunológico sigue funcionando bien, salvo en este aspecto).

Otra causa común de la insuficiencia tiroidea se debe al tratamiento previo de una condición denominada hipertiroidismo. Cuando se ha utilizado yodo radioactivo o cirugía tiroidea para controlar esta condición, la tiroides suele reducir demasiado su actividad, a veces al cabo de varios años. Existen también otras causas poco comunes que reducen la actividad de la tiroides, incluyendo algunas enfermedades que impiden que la glándula pituitaria produzca suficiente TSH.

DIAGNÓSTICO

Es muy importante confirmar el diagnóstico por medio de un análisis de sangre a fin de asegurarse de que los síntomas de una persona son realmente causados por el hipotiroidismo y de que se aliviarán con el tratamiento a base de levotiroxina.

Los análisis precisos y confiables que se hacen en el laboratorio pueden determinar los niveles de T4 y TSH en la sangre. Las personas cuya glándula tiroides funciona por debajo de lo normal tendrán un nivel bajo de T4 en la sangre, a la vez que tienen un alto nivel de TSH.

Su médico examinará los resultados de los análisis y del examen clínico y prescribirá un plan de tratamiento.

A las cuatro semanas de iniciado el tratamiento se pueden realizar los mismos análisis con el fin de determinar si la dósis de levotiroxina administrada a la persona que padece de hipotiroidismo es o no la correcta. A veces también se examinan las muestras de sangre para comprobar la existencia de anticuerpos contra la tiroides, que es un indicio de tiroiditis inmunológica.

Después de que se haya empezado el tratamiento contra el hipotiroidismo, es probable que el paciente lo deba continuar durante el resto de su vida. Por ello, es sumamente importante que el diagnóstico se determine de manera definitiva.

TRATAMIENTO

El tratamiento más satisfactorio es la administración de sodio de levotiroxina por vía oral, una vez al día, preferiblemente en las mañanas. Este medicamento, T4 puramente sintético, reemplaza el T4 que la glándula tiroides no puede segregar. Este medicamento se comercializa en diferentes intensidades, lo que significa que normalmente se puede hallar una dósis adecuada para cada paciente. La dósis se debe revaluar y posiblemente ajustar durante varios meses hasta que se encuentre la dósis exacta. A partir de ahí se debe hacer una evaluación de la dósis todos los años. Pregúntele a su médico cuándo debe acudir a la próxima consulta para evaluar nuevamente su dósis.

Es posible que los pacientes noten una ligera respuesta a la terapia en un plazo de 1 o 2 semanas, aunque la reacción metabólica completa a la terapia con hormonas tiroideas frecuentemente se demora. Quizás transcurran varias semanas después de que se restauren los niveles normales de hormonas tiroideas antes de que el paciente se vuelva a sentir completamente normal.

Es muy importante que al paciente se le administre la cantidad exacta de hormona tiroidea. Un continuo estado de fatiga, lentitud mental o la presencia de calambres musculares pueden indicar que la dosis es demasiado baja. Una dósis excesiva de hormona tiroidea puede provocar síntomas de nerviosismo, palpitaciones o insomnio.

Los estudios recientes indican que es posible que una cantidad excesiva de hormona tiroidea provoque una pérdida demasiado alta de calcio en los huesos. Esto aumentaría el riesgo de que el paciente desarrolle osteoporosis, es decir, la pérdida de consistencia ósea, que puede ocasionar la fractura de la cadera y de las vértebras.